

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

HARS · ESCALA DE HAMILTON PARA LA EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD

Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) – Patrón oro heteroaplicado de evaluación dimensional de ansiedad psíquica y somática

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS / HAM-A)
Autor Original	Max Hamilton (1959)
Validación Española	Bulbena et al. (Grup Sant Pau, 1994); Lobo et al. (2002); Bobes et al. (2004)
Tipo de Instrumento	Escala de entrevista clínica semiestructurada heteroaplicada
Población Diana	Pacientes adultos diagnosticados de trastornos neuróticos / trastornos de ansiedad
Tiempo de Aplicación	15 a 20 minutos (administrada por clínico entrenado)
Formato de Respuesta	Escala tipo Likert de 5 puntos: 0 (Ausente) a 4 (Muy grave / incapacitante)
Finalidad Clínica	Cuantificación de la gravedad global de la ansiedad, diferenciación de componentes psíquicos vs somáticos y medición de eficacia terapéutica en ensayos clínicos

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

Publicada originalmente por Max Hamilton en la Universidad de Leeds en 1959, la HARS se estableció como la primera escala dimensional estandarizada para cuantificar la intensidad de los estados de ansiedad en pacientes ambulatorios psiquiátricos. Hamilton concibió la ansiedad no como un síntoma meramente cognitivo, sino como una afección psicobiológica integral donde las manifestaciones somáticas autonómicas desempeñan un papel central en la vivencia de malestar del sujeto.

El instrumento opera a través de un modelo bifactorial universalmente reconocido: a) **Ansiedad Psíquica**, que recoge el estado de ánimo aprensivo, la tensión subjetiva, el insomnio, los temores indefinidos y la dificultad de concentración intelectual; y b) **Ansiedad Somática**, que mide la descarga vegetativa simpática y parasimpática en los sistemas cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, genitourinario y neuromuscular, culminando en la observación de la conducta ansiosa en la entrevista.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dimensión Clínica	Nº Ítems	Ítems Constituyentes y Áreas Evaluadas
Ansiedad Psíquica	7 ítems	Ítems 1 a 6 y 14: Estado de ánimo ansioso, tensión, miedos, insomnio, dificultades intelectuales/cognitivas, ánimo deprimido y conducta durante la entrevista.
Ansiedad Somática	7 ítems	Ítems 7 a 13: Síntomas somáticos musculares (mialgias, rigidez), sensoriales (tinnitus, visión borrosa), cardiovasculares (taquicardia), respiratorios (disnea), gastrointestinales (dispepsia), genitourinarios y autonómicos (sudoración, boca seca).
Puntuación Total HARS	14 ítems	Suma global de los 14 ítems (Rango: 0 a 56 puntos).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · HARS

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach de 0.89 a 0.92 en la validación española de Lobo et al. (2002). Subescala Psíquica = 0.86; Subescala Somática = 0.84.
Fiabilidad Inter-Jueces	Excelente concordancia inter-evaluador (ICC = 0.88 a 0.94) entre profesionales médicos y psicólogos clínicos debidamente formados.
Validez Concurrente	Correlación elevada con el STAI-Estado ($r = 0.73$), con el inventario de Beck (BAI, $r = 0.79$) y con la Escala de Depresión de Hamilton (HDRS, $r = 0.64$).
Sensibilidad Terapéutica	Patrón oro en psicofarmacología internacional para monitorizar la eficacia de ansiolíticos (ISRS, IRSN, pregabalina, benzodiacepinas).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Calificación Heteroaplicada de Cada Ítem (0 a 4):**
 - 0 = Ausente; 1 = Leve; 2 = Moderado; 3 = Grave; 4 = Muy grave / totalmente incapacitante.
- Cálculo de Subtotales:**
 - Subtotal Ansiedad Psíquica:** Suma de ítems 1 a 6 + ítem 14 (Rango: 0 a 28).
 - Subtotal Ansiedad Somática:** Suma de ítems 7 a 13 (Rango: 0 a 28).
- Puntuación Global Compuesta:** Suma de todos los reactivos (Rango: 0 a 56 puntos).
- Criterio Estándar de Respuesta:** Reducción $\geq 50\%$ respecto al valor basal pretratamiento.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación HARS	Estratificación	Grado de Afectación	Directriz Asistencial y Farmacológica
0 a 13 puntos	Sin Ansiedad / Normal	Asintomático	No requiere intervención activa. Estado normativo.
14 a 17 puntos	Ansiedad Leve	Subclínica	Pautas de relajación diafragmática y psicoeducación.
18 a 24 puntos	Ansiedad Moderada	Significativa	Tratamiento formal: TCC y/o fármacos ansiolíticos.
25 a 56 puntos	Ansiedad Grave / Severa	Incapacitante	Manejo combinado intensivo; seguimiento estrecho.

PUNTO DE CORTE DE REMISIÓN CLÍNICA (HARS ≤ 7): En ensayos clínicos y en la práctica médica ambulatoria, la remisión clínica completa del trastorno de ansiedad se define formalmente como la obtención de una puntuación total en la HARS menor o igual a 7 puntos mantenida en el tiempo.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · HARS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Entrevista Clínica Diagnóstica: Evaluar al paciente interrogando sobre la última semana previa.

Paso 2: Análisis del Perfil Dimensional:

- **Si HARS Total < 14:** Ansiedad no patológica. Refuerzo de hábitos de vida saludables.
- **Si HARS Total $\geq$ 14 con predominio Somático (Puntuación Somática > Psíquica):**
 1. Investigar somatizaciones, cefaleas o colon irritable comórbidos.
 2. Considerar pregabalina o betabloqueantes en dosis bajas si domina la hiperactivación adrenérgica.
- **Si HARS Total $\geq$ 18 con predominio Psíquico (Puntuación Psíquica > Somática):**
 1. Iniciar ISRS (escitalopram, sertralina) o IRSN (duloxetine, venlafaxina) asociado a TCC focalizada en intolerancia a la incertidumbre.
 2. Benzodiacepinas de vida media intermedia únicamente como puente terapéutico durante las primeras 2-3 semanas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Mujer de 45 años, profesora de instituto, acude a la Unidad de Salud Mental por insomnio pertinaz, dolor cervical crónico, mareo subjetivo constante y angustia difusa que interfiere con su labor docente.

Evaluación Psicométrica Inicial en HARS: Total = 31 / 56 puntos (Ansiedad Grave / Severa).

- **Subescala Psíquica:** 17 / 28 puntos. Estado aprensivo continuo (ítem 1 = 3), tensión mental (ítem 2 = 3), insomnio de conciliación (ítem 4 = 3) y fallos de concentración (ítem 5 = 3).
- **Subescala Somática:** 14 / 28 puntos. Mialgias y temblores finos (ítem 7 = 3), opresión retroesternal (ítem 9 = 2) y sequedad de boca con deglución difícil (ítem 13 = 2).

Manejo Terapéutico: Se diagnosticó Trastorno de Ansiedad Generalizada severo. Se inició tratamiento con escitalopram (titulado a 15 mg/día) y psicoterapia cognitivo-conductual centrada en reestructuración de pensamientos aprensivos y relajación muscular progresiva de Jacobson. En la revisión a las 8 semanas, la puntuación total en la HARS se redujo a 8 puntos (descenso del 74.2%), alcanzando criterios de respuesta terapéutica y remisión clínica.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CRÍTICAS DE SEGURIDAD

- Una puntuación de 3 o 4 en el ítem 6 (ánimo deprimido) obliga a evaluar formalmente la depresión mayor comórbida y el riesgo suicida.
- La dependencia física a benzodiacepinas puede simular un rebote de ansiedad somática al suspender dosis bruscamente.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Patología Orgánica Autonómica:** Feocromocitoma, taquicardia paroxística supraventricular, hipertiroidismo o asma bronquial.
- **Trastorno de Pánico:** La HARS evalúa ansiedad generalizada persistente; en ataques agudos paroxísticos complementar con PDSS.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety states by rating. *British Journal of Medical Psychology*, 32(1), 50–55.
- Lobo, A., Chamorro, L., Luque, A., Dal-Ré, R., Badía, X., & Baró, E. (2002). Validación de las versiones en español de la Montgomery-Asberg Depression Rating Scale y la Hamilton Anxiety Rating Scale para la evaluación de la depresión y la ansiedad. *Medicina Clínica*, 118(13), 493–499.
- Bulbena, A., Martín-Santos, R., & Grupo Sant Pau. (1994). Escala de Hamilton para la Ansiedad (HARS): Adaptación y validación. *Actas Luso-Españolas de Neurología, Psiquiatría y Ciencias Afines*, 22(5), 231–237.
- Maier, W., Buller, R., Philipp, M., & Heuser, I. (1988). The Hamilton Anxiety Scale: Reliability, validity and sensitivity to change in anxiety and depressive disorders. *Journal of Affective Disorders*, 14(1), 61–68.